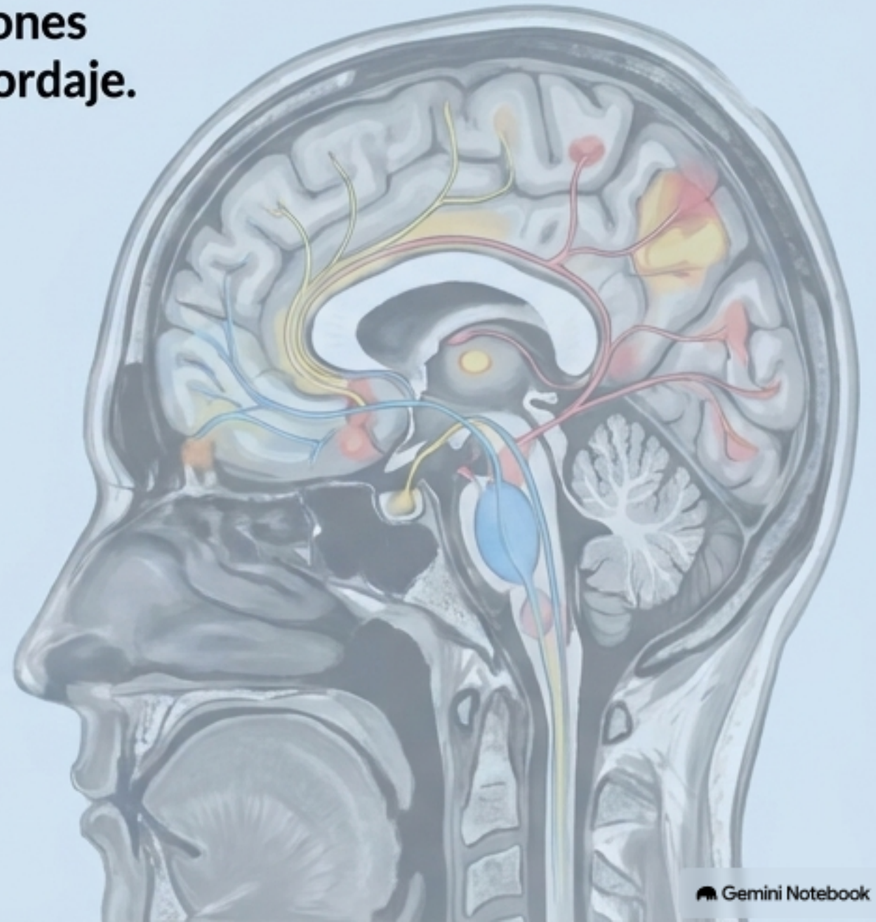
Trastornos de la personalidad: Cluster B

Cuatro patrones clínicos, sus manifestaciones interpersonales y los fundamentos de su abordaje.



Presentador:
Ponce Labella Franco Nicolas,
Residente de Psiquiatría.

American Psychiatric Association. DSM-5-TR. 2022.

Gemini Notebook

1

Trastorno límite de la personalidad (TLP)



- Inestabilidad generalizada en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos.
- Marcada impulsividad en diversas áreas (ej. gastos, sexo, sustancias).
- Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono real o imaginario.
- Sentimientos crónicos de vacio e ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés.

2

Trastorno narcisista de la personalidad (TNP)



- Patrón dominante de grandiosidad (en fantasía o comportamiento).
- Necesidad de admiración excesiva y falta de empatia.
- Sentimiento de privilegio (expectativas no razonables de trato favorable).
- Creencia de ser 'especial' y único, solo comprendido por otras personas de alto estatus.

3

Trastorno histriónico de la personalidad (THP)



- Patrón de emotividad excesiva y búsqueda de atención.
- Comportamiento seductor o provocativo inapropiado en la interacción.
- Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención.
- Estilo de habla excesivamente impresionista y carente de detalles.

4

Trastorno antisocial de la personalidad (TAP)



- Patrón generalizado de desprecio y violación de los derechos de los demás.
- Engaño, mentiras repetidas, uso de alias o estafa por provecho o placer.
- Irritabilidad y agresividad (peleas físicas repetidas, agresiones).
- Ausencia de remordimiento, indiferencia o racionalización del daño infligido.

¿Cómo recorreremos estos trastornos? → 1. Patrón clínico central → 2. Manifestación conductual → 3. Diagnóstico diferencial → 4. Intervenciones y evidencia

Idea clave: pertenecer al mismo cluster no significa compartir una única causa, mecanismo psicológico o pronóstico.

APA. DSM-5-TR. 2022; WHO. ICD-11. 2024; Sharp C, et al. World Psychiatry. 2025.

Gemini Notebook

Trastorno límite de la personalidad (TLP): criterios diagnósticos DSM-5-TR y analogía pedagógica

Criterios DSM-5-TR (≥5 de 9): Patrón general de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y los afectos, y una notable impulsividad, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos.

Afecto y Relaciones

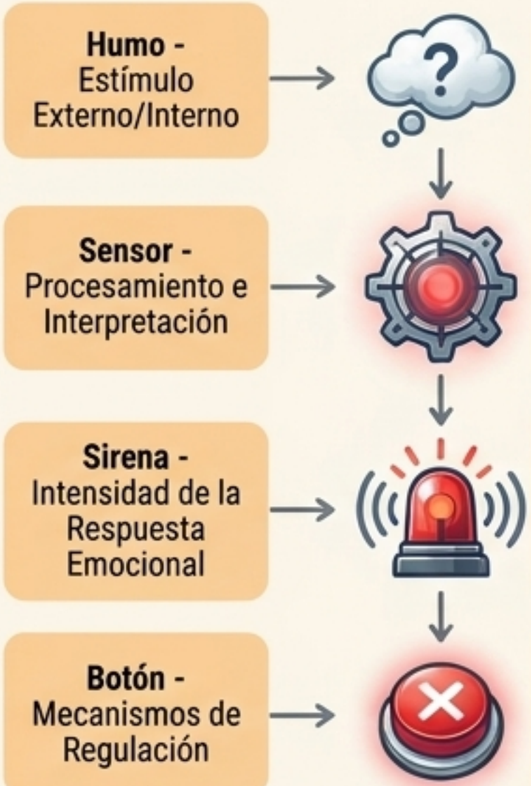
- **Inestabilidad afectiva** (reactividad notable del estado de ánimo, disforia, irritabilidad o ansiedad intensas que duran horas o raramente días).
- **Ira intensa o dificultad para controlarla** (inapropiada y persistente, p. ej., muestras constantes de enfado, peleas físicas).
- **Vacío crónico** (sentimientos persistentes de vacío, aburrimiento, falta de sentido).
- **Relaciones interpersonales inestables e intensas** (alternancia extrema entre la idealización y la devaluación).
- **Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono** (real o imaginado, incluye actos impulsivos).

Identidad e Impulsividad

- **Alteración de la identidad** (autoimagen o sentido del yo acusadamente y persistentemente inestable).
- **Impulsividad potencialmente perjudicial** (en al menos dos áreas, p. ej., gastos, sexo, drogas, atracones, conducción temeraria).
- **Conductas suicidas o autolesivas** (recurrentes: intentos, amenazas, gestos o automutilación).
- **Ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos graves** (relacionados con el estrés).

Estos criterios deben darse dentro de un patrón persistente y evaluado en su contexto clínico, cultural y evolutivo.

Analogía pedagógica detallada: La alarma de humo hipersensible y el sistema de regulación emocional



Humo - Estímulo Externo/Interno → **Humo (Señal emocional/interpersonal)**
Percibido como amenaza inminente, sea real o no.
Ej: una crítica menor, una separación breve, un recuerdo doloroso.

Sensor - Procesamiento e Interpretación → **Sensor de Alarma (Respuesta emocional activada por umbral muy bajo)**
Umbral de activación extremadamente sensible; interpreta señales neutras o ambiguas como peligrosas, desencadenando una respuesta de lucha o huida.

Sirena - Intensidad de la Respuesta Emocional → **Sirena (Intensidad del malestar que dificulta pensar con flexibilidad)**
Intensidad desproporcionada del malestar emocional ('secuestro amigdalino'); bloques funciones ejecutivas, pensamiento claro y solución de problemas.

Botón - Mecanismos de Regulación → **Botón de reinicio (Dificultad para recuperar la calma y examinar la situación)**
Mecanismos de 'apagado' ineficaces o dañinos; la vuelta a la calma es lenta y difícil, perpetuando el ciclo de disregulación y las conductas impulsivas.

Límites cruciales de la analogía:

- No significa que el sufrimiento sea imaginario, sino que la señal de peligro es desproporcionada. Las señales no siempre son falsas, pero la reacción es exagerada. No explica por completo alteraciones de identidad o la impulsividad crónica.
- No es un mecanismo biológico único y demostrado, sino una herramienta conceptual para comprender la disregulación emocional.

APA. DSM-5-TR. 2022; Linehan MM. 1993; Bateman A, Fonagy P. 2016.

Gemini Notebook

Trastorno límite de la personalidad (TLP):
Regulación emocional, Mentalización y Evolución Longitudinal

Regulación Emocional: El Desafío de Gestionar el Afecto

Proceso clave para el bienestar

- Capacidad dinámica de:
  1. Identificar emociones con precisión,
  2. Tolerar el malestar sin desbordarse,
  3. Modular la intensidad y duración,
  4. Evitar que la emoción dicte la conducta.
- Influye en:
  - Cómo se procesan e interpretan situaciones interpersonales, y la modulación de respuestas emocionales inmediatas para una adaptación saludable.
- Consecuencia de la desregulación:
  - Respuestas intensas, impulsivas y perjudiciales.

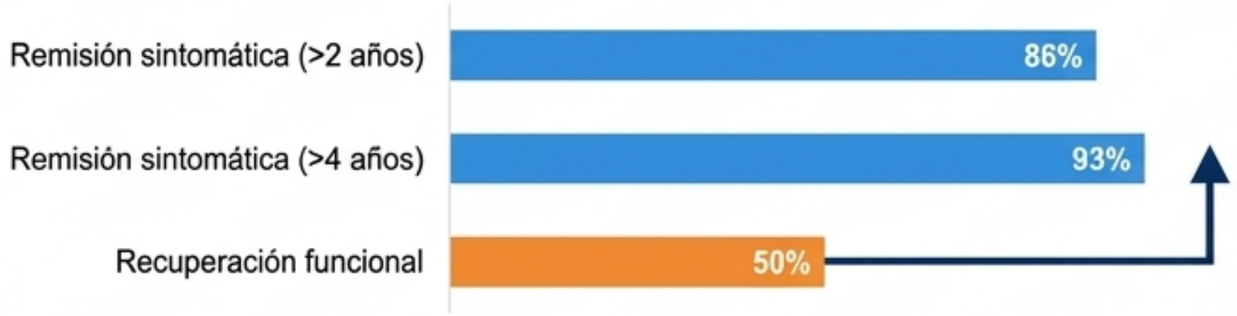
Mentalización: Comprendiendo la Mente Propia y Ajena

La base de las relaciones sociales

- Capacidad fundamental para:
  - Percibir y comprender conductas (propias y de otros) en términos de estados mentales (intenciones, deseos, emociones, creencias). **Nota**: No siempre es certera, es una interpretación.
- Impacto crítico: Afecta la interpretación de interacciones sociales y la intensidad de la reacción emocional subsiguiente.
  - Fomenta la empatia y la comunicación efectiva.

Situación Social (ej. "No respondió mi mensaje") → **Interpretación Mentalizadora** (ej. "Estará ocupado", "Quizás no lo vio") → **Reacción Emocional Regulada / Interpretación No Mentalizadora** (ej. "Ya no le importo", "Me está ignorando") → **Reacción Emocional Desregulada**

Evolución Longitudinal a 10 Años (Zanarini et al., 2010): Remisión vs. Recuperación



Idea Clave: La Remisión Sintomática NO Equivale a Recuperación Funcional Completa

Explicación: Una persona puede dejar de cumplir los criterios diagnósticos del TLP (remisión) y, sin embargo, continuar experimentando dificultades significativas en áreas clave de la vida como el funcionamiento social, laboral o académico, y necesitar apoyo continuo para recuperar la autonomia plena y el bienestar integral. Subraya la importancia de abordar ambas dimensiones en el tratamiento.

Nota: Los resultados proceden de una cohorte clínica específica y no deben generalizarse automáticamente a todas las personas con TLP.

APA. DSM-5-TR. 2022; Zanarini MC, et al. Am J Psychiatry. 2010; Bateman A, Fonagy P. 2016.

Gemini Notebook

Trastorno límite de la personalidad (TLP): psicoterapias y evidencia

DBT (Dialéctico-conductual)



Foco principal: Equilibrio entre aceptación y cambio

- Entrenamiento en habilidades: Mindfulness, Tolerancia al malestar, Regulación emocional, Efectividad interpersonal.
- Estrategias de validación y modificación de conducta.
- **Objetivo:** Reducir conductas autolesivas, mejorar calidad de vida, aumentar habilidades de afrontamiento.

MBT (Mentalización)



Foco principal: Fortalecer la capacidad de mentalizar

- Comprender estados mentales propios y ajenos en el contexto de apego.
- Restaurar la mentalización bajo estrés emocional.
- **Objetivo:** Mejorar la regulación del afecto, relaciones interpersonales y el sentido de identidad.

Terapia de Esquemas



Foco principal: Modificar esquemas disfuncionales tempranos

- Identificar patrones de pensamiento y conducta arraigados (esquemas).
- Técnicas experienciales (imaginación), cognitivas y conductuales.
- **Objetivo:** Promover modos de adulto saludable y satisfacer necesidades emocionales básicas.

TFP (Focalizada en la Transferencia)



Foco principal: Exploración de la transferencia y la escisión

- Análisis de la relación paciente-terapeuta en el aquí y ahora.
- Integración de representaciones escindidas (bueno/malo) de sí mismo y otros.
- **Objetivo:** Lograr una identidad más coherente y mejorar el funcionamiento interpersonal.

Evidencia y Limitaciones (Crotty et al., 2024)

Resultados favorables para múltiples psicoterapias especializadas. Limitaciones en estudios (tamaño muestral, heterogeneidad) impiden declarar una superioridad universal definitiva. La elección del tratamiento debe basarse en las necesidades individuales del paciente, la etapa del trastorno y la disponibilidad de recursos. El objetivo terapéutico es crucial.



Perla clínica: Medicación

No existe un fármaco aprobado específicamente para tratar el TLP de manera global. El uso de medicación debe ser sintomático y dirigido a problemas específicos co-ocurrentes (ej. depresión mayor, ansiedad severa, impulsividad aguda), con objetivos claros, monitoreo estrecho de efectos secundarios y reevaluación periódica de su necesidad.

Linehan MM, et al. 1991; Crotty K, et al. *J Consult Clin Psychol*. 2024

Gemini Notebook

Trastorno narcisista de la personalidad (TNP): grandiosidad y vulnerabilidad

Grandiosidad

- Sentido exagerado de autoimportancia y superioridad.
- Fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez o belleza.
- Creencia de ser "especial" y único, requiriendo admiración excesiva.
- Sentido de derecho (entitlement) y expectativas de trato favorable.

Vulnerabilidad

- Hipersensibilidad a la crítica, al fracaso o a la desaprobación.
- Sentimientos profundos de vergüenza, humillación o vacío ante la amenaza a la autoestima.
- Tendencia al retraimiento social o a la reactividad emocional intensa (ira, resentimiento).

Impacto Interpersonal
Las dinámicas de búsqueda de validación (grandiosidad) y la defensa ante la crítica (vulnerabilidad) generan inestabilidad y conflictos significativos en las relaciones, afectando su calidad y duración.



Sistema de Regulación de la Autoestima

1. Búsqueda activa de aprobación y admiración externa.
2. Defensa agresiva de la posición de superioridad ante amenazas.
3. Descalificación o devaluación de la fuente de crítica.

Analogía del Termostato

Representa la oscilación de la autoestima entre la inflación (grandiosidad) y la deflación (vulnerabilidad) en respuesta al feedback externo.
Importante: No describe a todas las personas con TNP; la intensidad y frecuencia de las fluctuaciones varían.

Aclaración Clínica:
Grandiosidad y vulnerabilidad son dimensiones útiles para comprender la presentación clínica, pero NO son subtipos diagnósticos oficiales ni criterios formales del DSM-5-TR. TNP no se reduce a vanidad o egoísmo.

Gemini Notebook

Trastorno narcisista de la personalidad (TNP): empatía y abordaje clínico

Empatía cognitiva:
Comprender lo que el otro piensa/siente.

+

Empatía emocional:
Experimentar respuesta afectiva ante el estado del otro.

+

Conducta prosocial:
Actuar orientado al bienestar ajeno.

Las dificultades en una dimensión no demuestran una ausencia total de empatía en todas las situaciones.

Ensayo Mohajerin 2026 (114 pacientes): Comparación y Definiciones

Terapia de Esquemas (ST)

Foco en identificar y modificar esquemas disfuncionales tempranos y modos de desadaptativos. Busca satisfacer necesidades emocionales básicas no cubiertas en la infancia y promover patrones de relación saludables.

Resultados: Reducción de síntomas; mayor eficacia en la modificación de patrones interpersonales arraigados.

Protocolo Unificado (UP)

Enfoque transdiagnóstico (Barlow et al.) que aborda los procesos de regulación emocional subyacentes a los trastornos emocionales. Enseña habilidades de conciencia, flexibilidad cognitiva y exposición interoceptiva.

Resultados: Reducción de síntomas; mayor eficacia en la regulación de la reactividad emocional aguda.

Limitaciones y Conclusión: Comparar dos tratamientos activos no permite demostrar que superen la ausencia de tratamiento ni establecer una terapia universalmente superior. Se requieren estudios con grupos control.



Perla clínica:
Describir el patrón interpersonal concreto es más útil que utilizar «narcisista» como sinónimo de egoísmo o arrogancia. La precisión descriptiva mejora la comunicación clínica.

Pincus AL, Lukowitsky MR. 2010; Mohajerin B, et al. Clin Psychol Psychother. 2026.

Gemini Notebook

Trastorno histriónico de la personalidad (THP): características clínicas

Características Clínicas Principales

- **Cognitivo/Emocional**: Necesidad de ser el centro de atención (incomodidad si no lo es).
- Expresión emocional cambiante y superficial.
- Estilo impresionista del discurso, carente de detalles.
- Sugestibilidad, fácilmente influenciable.
- **Conductual/Interpersonal**: Interacción seductora o provocativa inapropiada.
- Uso de la apariencia física para atraer atención.
- Dramatización, teatralidad y expresión emocional exagerada.
- Percepción de las relaciones como más íntimas de lo que son.

Se requiere un patrón persistente de cinco (5) o más criterios para el diagnóstico clínico.

El micrófono conectado (Analogía)



1. **Conexión/Presencia**: Micrófono activo, busca retroalimentación constante (Atención).
2. **Pérdida de Señal**: Desatención del entorno, disminución del volumen (Incomodidad).
3. **Reconexión Intensa**: Aumento brusco de volumen, intensificación para recuperar señal (Reacción exagerada).

Límites y Diferenciación Clínica

Límites de la analogía: Describe una dinámica de atención, no una manipulación deliberada ni emociones falsas.

Diferenciación Clínica: Se distingue de la expresividad y sociabilidad normales. La emoción no es fingida, sino intensificada.

Gemini Notebook

Trastorno histriónico de la personalidad (THP): diagnóstico diferencial

Nota: Una manifestación aislada no establece un diagnóstico. Se requiere un patrón generalizado y persistente.

Rasgo Compartido / Manifestación	Diagnóstico Alternativo a Considerar	Clave para la Diferenciación (Lo que distingue al THP)
Estilo comunicativo intenso, teatralidad, dramatización.	**Expresividad normal** (Variante de la normalidad)	• ***Inflexibilidad y Desadaptación***: El patrón es rígido y causa deterioro funcional significativo en *múltiples* contextos. • ***Contexto Cultural***: La conducta es desproporcionada para las normas culturales.
Búsqueda de atención, emotividad lábil, energía elevada aparente.	**Trastorno Bipolar (Manía / Hipomanía)**	• ***Curso Episódico vs. Patrón Estable***: La manía tiene un inicio y fin definidos; el THP es un rasgo persistente. • ***Síntomas Nucleares***: Presencia de grandiosidad, disminución de necesidad de sueño, fuga de ideas.
Emotividad intensa, impulsividad, relaciones inestables.	**Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)**	• ***Inestabilidad Reactiva***: La desregulación en TLP suele ser reactiva a estresores interpersonales (miedo al abandono). • ***Síntomas Nucleares de TLP***: Sentimientos crónicos de vacío, alteraciones de la identidad, autolesiones.

Contexto Crítico: Validez del Constructo

🔍 **Estudio Clave (Bakkevig & Karterud, 2010)**: Analizó criterios DSM-IV en una gran muestra clínica noruega (N=2289).

📊 **Resultados**: Prevalencia muy baja (0.4%) y consistencia interna baja de los criterios.

❓ **Implicación**: Cuestiona la validez y utilidad del diagnóstico. *No demuestra que el THP no exista*, pero sugiere cautela para evitar la sobre-patologización o estereotipos. La conclusión requiere cautela al basarse en impresiones.

Bakkevig J, Karterud S. 2010; APA. DSM-5-TR. 2022.

Gemini Notebook

Trastorno antisocial de la personalidad (TAP): patrón clínico



El GPS del beneficio inmediato



Ruta A: Ganancia Inmediata

- Priorización de la recompensa a corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo.
- Impulsividad, baja tolerancia a la frustración, búsqueda de sensaciones.
- Riesgos ignorados.

Costos acumulativos (daños, consecuencias legales/sociales)

Ruta B: Evaluación a largo plazo

- Evaluación de riesgos y beneficios a futuro, planificación, anticipación de castigos. Función ejecutiva disminuida en este contexto.

Límites de la analogía:
No implica incapacidad total para anticipar consecuencias, ni ausencia universal de remordimiento. Describe una tendencia a priorizar recompensas inmediatas y subestimar costos futuros.

Nota: No toda persona con TAP delinque ni todas carecen de remordimiento. Son conceptos relacionados pero no equivalentes.

APA. DS

Gemini Notebook

Trastorno antisocial de la personalidad (TAP): evaluación y abordaje

Historia evolutiva y Criterios Previos

- Diagnóstico requiere edad mínima de 18 años.
- Evidencia de Trastorno de Conducta (TC) con inicio antes de los 15 años.
- Ejemplos de TC: Agresión a personas/animales, destrucción de propiedad, engaño/robo, violaciones graves de normas.

Patrón Persistente en Distintos Contextos

- Persistencia de patrón de desprecio y violación de derechos (≥3 criterios DSM-5) desde los 15 años.
- Manifestaciones clave: Impulsividad, engaño, irresponsabilidad, irritabilidad/agresividad, despreocupación por seguridad, ausencia de remordimiento.
- Debe ocurrir en múltiples ámbitos (familiar, laboral, social) y no exclusivamente durante esquizofrenia o trastorno bipolar.

Comorbilidades y Factores Asociados

- Rol crífico del Trastorno por Consumo de Sustancias (TCS).
- Alta prevelencia de otros trastornos mentales: TDAH, Trastornos de ansiedad, Trastornos depresivos, Otros trastornos de personalidad (p. ej., Límite, Narcisista).
- Comorbilidad complica el curso, evaluación y respuesta al tratamiento.

Evaluación del Riesgo Actual (Dinámico vs. Estático)

- Diferenciar factores históricos (estáticos, no modificables; p. ej., historial delictivo) de factores dinámicos (actuales, modificables).
- Factores dinámicos a evaluar: Consumo activo de sustancias, falta de apoyo social, impulsividad actual, acceso a armas, incumplimiento de tratamiento.
- **Objetivo:** Gestión y mitigación del riesgo, no solo predicción. No equiparar diagnóstico con peligrosidad inminente.

Revisión Cochrane 2020 (Intervenciones Psicológicas)

Certeza baja/muy baja. La evidencia actual de tratamientos psicológicos es limitada. Ninguna intervención específica presentó evidencia convincente de cambio generalizado en el comportamiento antisocial. Esto subraye la necesidad de mas investigación y no descarta la utilidad de intervenciones individualizadas, pero impide conclusiones firmes universales.

Perla clínica

El diagnóstico de TAP no sustituye la evaluación del riesgo actual. El riesgo de violencia o reincidencia debe valorarse de forma específica, contextualizada y revisable, considerando factores dinámicos.

Gemini Notebook

Cluster B: comparación clínica de los cuatro trastornos

	Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)	Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP)	Trastorno Histriónico de la Personalidad (THP)	Trastorno Antisocial de la Personalidad (TAP)
Patrón clínico central	Inestabilidad generalizada y profunda (afecto, identidad, relaciones interpersonales) e impulsividad notable. *Miedo intenso al abandono.*	Grandiosidad (en fantasía o comportamiento), necesidad profunda de admiración y falta de empatía. *Sentido exagerado de autoimportancia.*	Emotividad excesiva y búsqueda constante de atención. *Incomodidad cuando no es el centro de atención.* Comportamiento teatral o seductor.	Desprecio y vulneración persistente de los derechos de los demás, que ocurre desde los 15 años. *Engaño, impulsividad, irritabilidad, irresponsabilidad, falta de remordimiento.*
Pregunta orientadora	¿Cómo se regula ante el estrés interpersonal, maneja la disforia y recupera el equilibrio emocional? *¿Existen esfuerzos frenéticos para evitar el abandono?*	¿Cómo reacciona ante la falta de reconocimiento o la crítica, y cómo afecta esto a su frágil autoimagen grandiosa? *¿Existen fantasías de éxito ilimitado?*	¿Cómo organiza su conducta y expresión del afecto, y qué sucede cuando no logra ser el centro de atención? *¿Utiliza la apariencia física para llamar la atención?*	¿Qué patrón evolutivo de conducta (desde la infancia/adolescencia) explica las transgresiones recurrentes de normas? *¿Hay evidencia de trastorno de conducta antes de los 15 años?*
Error que debe evitarse	Reducir el cuadro a conductas aisladas (p. ej., autolesiones, intentos de suicidio) sin ver el patrón subyacente de desregulación.	Confundir la grandiosidad patológica (defensiva, frágil) con rasgos de ambición, seguridad o alta autoestima saludable.	Interpretar la teatralidad o superficialidad como una expresión emocional genuina o profunda, ignorando la función de búsqueda de atención.	Equiparar la conducta delictiva con el trastorno, ignorando otros factores (sociales, contextuales) o confundir con otros trastornos (p. ej., consumo de sustancias).

Nota: La tabla orienta la entrevista clínica; no sustituye la evaluación exhaustiva de criterios formales ni del contexto.

APA. DSM-5-TR. 2022; WHO. ICD-11. 2024; Sharp C, et al. 2025.

Gemini Notebook

Cluster B: de los síntomas a la formulación clínica

1. Describir conductas observables
(Sin etiquetas)

¿Qué hace, dice, siente o interpreta? Describir hechos concretos, evitando juicios y diagnósticos prematuros.

2. Reconstruir su evolución
(Línea de tiempo y patrones)

¿Desde cuándo? ¿Es un patrón persistente o episódico? ¿Qué eventos lo desencadenaron?

3. Identificar antecedentes y consecuencias
(Análisis Funcional)

Contexto -> Significado -> Emoción -> Conducta -> Consecuencia. ¿Qué precede y qué sigue a la conducta?

4. Formular hipótesis iniciales
(Integrar información)

Integrar la información para generar explicaciones clínicas tentativas sobre la función de la conducta.

5. Contrastar con alternativas
(Refutar hipótesis)

Buscar diagnósticos diferenciales y evidencia que descarte la hipótesis inicial para refinar el entendimiento.

6. Definir objetivos clínicos evaluables
(Plan de tratamiento)

Establecer metas concretas, medibles y alcanzables para la intervención basadas en la formulación.

Ejemplo de razonamiento (misma conducta, diferente explicación):

Conducta observable: Arrebato de ira intensa ante una crítica menor.

Contexto 1 (TLP): Si es reactiva al miedo al abandono y se disipa rápidamente al restablecer conexión, la hipótesis se inclina hacia TLP.

Contexto 2 (TNP): Si es fría, calculada y surge de una amenaza a la autoimagen grandiosa por falta de reconocimiento, la hipótesis apunta hacia TNP.

Contexto 3 (THP): Si es teatral, busca atención, es superficial y parece una actuación emocional, la hipótesis sugiere THP.

Contexto 4 (TAP): Si es instrumental, para intimidar, conseguir un objetivo o evitar consecuencias, la hipótesis se orienta hacia TAP.

Conclusión (Clave Pedagógica): La misma conducta requiere entender su función, contexto y patrón para formular una hipótesis clínica válida; evita la etiqueta rápida.

APA. DSM-5-TR. 2022; WHO. ICD-11. 2024; Sharp C, et al. 2025.

Gemini Notebook

Bibliografía Esencial

Clasificación y modelos

- American Psychiatric Association. DSM-5-TR. 2022.
- World Health Organization. ICD-11. 2024.
- Sharp C, et al. World Psychiatry. 2025;24(3):319–340.

Trastorno límite de la personalidad

- Linehan MM. Cognitive-Behavioral Treatment of BPD. 1993.
- Linehan MM, et al. Arch Gen Psychiatry. 1991;48(12):1060–1064.
- Zanarini MC, et al. Am J Psychiatry. 2010;167(6):663–667.
- Crotty K, et al. J Consult Clin Psychol. 2024;92(5):275–295.
- NICE. Borderline personality disorder. CG78.

Trastorno narcisista de la personalidad

- Pincus AL, Lukowitsky MR. Annu Rev Clin Psychol. 2010;6:421–446.
- Mohajerin B, Howard R, Pincus AL. Clin Psychol Psychother. 2026;33(2):e70247.

Trastorno histriónico de la personalidad

- Bakkevig J, Karterud S. Compr Psychiatry. 2010;51(5):462–470.

Trastorno antisocial de la personalidad

- Gibbon S, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;9:CD007668.
- NICE. Antisocial personality disorder. CG77.

Gemini Notebook